EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
INTERVENCIÓN – PRODUCTIVIDAD DE LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS

Elemento	Descripción
Problema / Necesidad de Salud	La demanda de servicios de salud aumenta cada vez más en el mundo y aunque los recursos destinados al gasto público en salud también se han incrementado, estos siempre serán limitados (Palmer S, s.f.): las necesidades presupuestarias en salud son ilimitadas, sin embargo, ocurre todo lo contrario con los recursos (Pavarés, 2010). Lograr instituciones eficientes conlleva aunar las disminuciones del gasto, con el análisis sistemático de su relación con los resultados alcanzados y en comparación con unidades de objeto social similar y de acuerdo con las escalas de producción (Dilla, T,2009) Se debe realizar una correcta planificación de las necesidades de cada área y el ajuste del gasto al dinero asignado (Pavarés, 2010) por tanto surge la necesidad de implementar sistemas de monitoreo y evaluación que propicien el logro de los objetivos planteados en forma eficiente, eficaz y en lo posible con un alto grado de efectividad. En ese respecto, la institución presenta debilidades, no logrando, por ejemplo, implementar un sistema de costeo 100% eficiente. Esto obliga a la administración a utilizar indicadores de seguimiento más relacionados con la medición de la productividad (relación entre recursos y resultados, ejemplo cantidad de consultas por hora) que a indicadores de eficiencia propiamente dichos (costo de producción por unidad, ejemplo costo de una consulta en servicios específicos) Pero ¿Cuál es la importancia de lograr optimizar la productividad de los servicios en salud prestados a la población demandante asignada? Existe un impacto positivo sobre el nivel alcanzado en la resolución de problemáticas que afectan el estado de salud de un individuo cuando el abordaje desde los servicios de salud es oportuno y de calidad, resultando que, si se asegura parámetros de productividad adecuados, con utilización eficiente de los recursos, es más probable que se alcance ese abordaje óptimo, merced a una distribución más equitativa y suficiente. La problemática consiste en que no se ha logrado optimizar el uso de esos recursos: “En el informe de la Sugess del 2002, se documenta que el 28,7% de los pacientes en espera son "casos nuevos" y el 71 ,3% son "casos subsecuentes". Podemos deducir que casi 3 de cada 4 citas son originadas por los mismos médicos especialistas al establecer citas de control subsecuentes. La gran incógnita es cuántos de esos pacientes pueden continuar su control médico en el primero o segundo nivel con una contrarreferencia bien orientada, y cuántos efectivamente requieren continuar control y seguimiento en el tercer nivel.” (Díaz Salazar, 2003)
Evidencia	La temática se puede manejar desde múltiples aristas, siendo que todas demuestran la bondad que el manejo eficiente de los recursos hospitalarios produce sobre los procesos y resultados de la atención. Como ejemplo y por tratarse del eje sobre el que gira la razón de ser de los servicios de salud, interesa hacer mención del impacto sobre el resultado clínico que la atención oportuna asociada a una utilización eficiente y ordenada de los servicios conlleva, incluyendo aportes desde la disminución las listas de espera hasta la disponibilidad en tiempo para la atención inmediata de condiciones de urgencias, tenemos que el manejo farmacológico oportuno del infarto agudo de miocardio demuestra una disminución de la mortalidad

	inmediata del 6,7% al 3,8% y de mortalidad y re infarto a los 6 meses del 13,2% al 7,4%, p<0,01. (Pinar, 2009)
Consideraciones de Implementación	Barreras: Recursos limitados para satisfacer una demanda creciente de atenciones en salud y poca claridad respecto a la forma en que se distribuyen y aprovechan esos recursos. Poca sistematización en el seguimiento y estandarización de la Cultura organizativa y clima de trabajo en las distintas unidades funcionales de prestación del servicio. Existe un gran reservorio de información (EDUS), un porcentaje significativo de la cual no está sistematizada o con insuficientes herramientas para el reporte. Por ello todavía se percibe la necesidad local de satisfacer requerimientos para el seguimiento y monitoreo con herramientas individualizadas que complementan al EDUS, generalmente no difundidas, a veces poco estructuradas, lo que genera multiplicidad de reservorios de información valiosa, no estandarizada, que conlleva a la omisión en el registro de datos oficializados. Estrategias: Inclusión de herramientas para el monitoreo y control de los recursos, determinación de parámetros idóneos de funcionamiento y asignación de responsabilidades enfocadas en la mejora continua de los procesos desarrollados. Descripción y fortalecimiento de las buenas prácticas técnicas, clínicas y de relación intergrupal Implementación de sistemas de seguimiento a la calidad del dato registrado. Reforzamiento del grupo encargado de implementar mejoras al reservorio de información oficial, tanto en el aspecto de registro y seguridad, como el de entrega de reportes para uso individualizado (atención clínica) como gerencial (monitoreo, evaluación y toma de decisiones)
Normativa Técnica	Plan para la atención oportuna de las personas. Comisión técnica institucional de lista de espera. Ficha técnica de indicadores hospitalarios y SOP Dashboard. AES Fichas de indicadores claves de desempeño de servicios de salud. AES.
Costo / Efectividad	Aunque no se identifica un estudio de cuantifique el efecto total de los beneficios costo efectivos de optimizar la productividad de los servicios en forma global, basta con indicar que todos los esfuerzos por aprovechar al máximo la capacidad instalada de la unidad y brindar atención oportuna en tiempo y forma a usuarios con distintas patologías, traerán como resultado que la inversión logística, de aprovisionamiento, infraestructura y recurso humano, apareje mejoras en la efectividad para resolver la condiciones de salud específicas.
Objetivo (s) de la Evaluación	Evaluar la producción de las distintas áreas hospitalarias a fin de identificar brechas entre los logros obtenidos y los parámetros objetivo-institucionales a fin de recomendar acciones generales para la elaboración de planes de correctivos cuando corresponda
Pregunta (s) de Evaluación	¿Son suficientes los recursos asignados a atención de la demanda de servicios de salud? En orden de prioridad, ¿cuáles son los recursos que requieren optimización o implementación?

	¿Es eficiente el uso de los limitados recursos destinados a la atención en los servicios de salud prestados por la institución? ¿Se puede mejorar la productividad en los servicios de salud hospitalarios y a disponible?
Indicadores asociados a la intervención	• Índice conjunto de utilización de tiempo en el servicio de emergencias • Índice compuesto de aprovechamiento del cupo en la consulta externa especializada • Rendimiento compuesto en el uso de la cama hospitalaria • Relación índice de estancia ajustado por el riesgo vs porcentaje de ocupación • Índice de mortalidad ajustado por el riesgo
Anexos	No aplica
Referencias Bibliográficas	Caja Costarricense de Seguro Social. Plan para la atención oportuna de las personas. Recuperado el 20 noviembre 2023, de https://repositorio.binasss.sa.cr/repositorio/bitstream/handle/20.500.11764/651/planatencion.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Díaz Salazar, Jorge. Persistencia de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social: un enfoque estratégico. Rev. cienc. adm. financ. segur. soc vol.11 n.2 San José Jan. 2003 Dilla T, González de Dios J, Sacristán JA. Evaluación Económica en Medicina (I): Fundamentos y Metodología. Evid Pediatr [Internet]. 2009 [citado 17 Feb 2017]; 5(3): [aprox. 9 p.]. Disponible en: http://www.aepap.org/EvidPediatr/numeros/vol5/2009_numero_3/2009_vol5_numero3.15.htm Galva, Roberto. 2002. "Informe de la Superintendencia General de Servicios de Salud sobre listas de espera del año 2002". Caja Costarricense de Seguro Social. San José, Costa Rica. George Q, Ramón, et al. Aspectos teóricos sobre eficacia, efectividad y eficiencia en los servicios de salud. Revista Información Científica, 96(6), 1153-1163,2017 Palmer S, Torgerson DJ. Definitions of efficiency. BMJ. 1999;318 (7191):1136. Payarés Comas B, Garnica Morales L. Cultura y economía en el desarrollo social humano. Rev Hum Med [Internet]. 2010 Dic [citado 17 Feb 2017];10(3):[aprox. 12 p.]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttex&pid=t1025-02552010000500020&lng=es Pinar, E; Bardoji, Alfredo. Manejo del infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Guías de actuación clínica y el mundo real. Rev Esp Cardiol Supl. 2009; 9:71C-78C